Ch. 1 – Prise de notes

Santé publique et promotion de la santé en nutrition · tout le cours en prise de notes

Abréviations : SP = santé publique · PS = promotion de la santé · EPS = éducation pour la santé · DT = déterminants · pop. = population · ≠ = différent de · → = donne / entraîne · ⊃ = contient

1. Concepts de santé

- **Biomédical** (XIXe-XXe) : santé = absence de maladie → curatif, individuel. Leriche 1936 : « silence des organes ».
- **OMS 1946** (en vigueur 7/04/1948) : « état de **complet bien-être physique, mental et social**, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».
  - positive + multidimensionnelle + **droit fondamental**
  - critique : « complet » = inatteignable ; statique
- **Engel 1977** : biopsychosocial (bio + psycho + social).
- **Ottawa 1986** : santé = **ressource de la vie quotidienne**, pas le but de la vie.
- Huber 2011 / Canguilhem 1943 : santé = **capacité d'adaptation**.
- **One Health** (OHHLEP 2021, Quadripartite OMS-FAO-OMSA-PNUE) : santé humaine + animale + écosystèmes. 60 % des maladies infectieuses = zoonoses. Ex. : menu végé EGalim.
- Santé **relative** : individuelle, variable, dynamique. Objective (mesurée) ≠ perçue (déclarée) ≠ positive (bien-être).
- Ottawa : conditions préalables = paix, abri, éducation, nourriture, revenu, écosystème stable, ressources durables, justice sociale, équité.
- Canguilhem 1943 (*Le normal et le pathologique*) : pouvoir tomber malade et s'en relever.
- One Health : principes de Manhattan 2004 ; plan d'action Quadripartite 2022-2026 ; guide BTS 2025 → toute action BC3 dans « Une seule santé ».
- Santé perçue : Baromètre SpF, enquête EHIS ; prédit la mortalité.
- Indicateurs d'état de santé : natalité, mortalité (infantile), espérance de vie, prévalence, incidence, IDH → Insee, Drees, SpF, ORS (ch. 2).

2. Santé publique

- **Winslow 1920** : « science et art de **prévenir** les maladies, **prolonger** la vie, **promouvoir** la santé par les **efforts coordonnés de la communauté** ». OMS 1952 reprend.
- OMS 1952 : ajoute santé mentale + « droit inné à la santé et à la longévité ». Lecture diét. : assainir le milieu (eau, offre alimentaire) ; maladies sociales (obésité, diabète, dénutrition) ; hygiène (EPS) ; diagnostic précoce (PMI, EHPAD) ; mesures sociales (aide alimentaire, cantine sociale).
- Formule courte : savoirs + actions organisées pour la santé **de la pop.**, en agissant **collectivement sur les DT**.
- **Histoire** : Antiquité-Renaissance = épidémies (Hippocrate *Airs, eaux, lieux* ; quarantaine Raguse 1377) · XVIIIe = l'État s'en mêle (statistiques, Jenner 1796) · XIXe = hygiénisme (Villermé 1840, Snow 1854, Pasteur, loi 1902) · XXe = protéger tous (ordonnances 1945 : Sécu, PMI ; OMS 1948 ; Alma-Ata 1978 ; Ottawa 1986 ; loi 1/07/1998 veille sanitaire) · XXIe = sécurité sanitaire, droits, territoires, climat.
- Clinique vs SP : cible (patient / pop.) · départ (prescription / diagnostic de situation) · objectif (guérir / améliorer + réduire inégalités) · leviers (bilan, ETP / environnements, politiques, éducation, plaidoyer) · acteurs (soignants / intersectoriel) · évaluation (patient / indicateurs de processus et de résultats).
- CSP **L. 1411-1** : politique de santé = État ; réduire inégalités sociales et territoriales.
- Clinique (1 patient, BC1) ≠ SP (pop., diagnostic, inégalités, intersectoriel, BC3).
- **9 missions** : observer, veiller, protéger | promouvoir, prévenir, éduquer (← diét.) | organiser, former-évaluer, gouverner.
- **Lois** : 1902 (1re loi SP) · 2002 (Kouchner, droits des malades) · 2004 (politique de SP, PNNS dans la loi, distributeurs interdits) · 2009 (HPST → ARS) · 2016 (modernisation → Nutri-Score, SNDS).
- **Paradoxe de Rose 1985** : bcp de gens à petit risque → + de cas que peu à haut risque → action populationnelle + dépistage.
  - calcul : cas = effectif × taux / 1 000 ; ex. 79 % des AVC chez les « faible risque ».

    - ex. : 100 000 adultes ; 5 000 × 10/1 000 = 50 AVC ; 95 000 × 2/1 000 = 190 AVC ; 190/240 = 79 %.
- 9 missions regroupées : connaissance-défense (observer, veiller, protéger) ; action (promouvoir, prévenir, éduquer) ; cadre (organiser, former-évaluer, gouverner).

3. Danger → risque

- **Danger** = capacité à nuire (*Listeria*, sel). **Exposition** = dose, durée, fréquence.
- **Risque** = probabilité = **danger × exposition**.
- Facteur de risque = **association**, pas forcément cause (Bradford Hill). Facteur de protection = allaitement, F&L, activité, soutien social.
- Problème de santé = altère la santé d'une pop., mesurable (fréquence, gravité, coût). Population à risque : femmes enceintes (listériose), âgés isolés (dénutrition).
- Chaîne : danger → exposition → risque → problème de santé (prévalence, incidence) ; FR ↑ la probabilité, FP ↓.

4. Les 4 modes d'intervention (guide 2025)

① **Surveillance / veille** : recueil continu ; veille = signal → alerte.

- **Santé publique France** (1/05/2016 = InVS + INPES + EPRUS + Adalis).
- Enquêtes : INCA (ANSES), ESTEBAN (SpF), NutriNet-Santé (2009), **Albane** (2025).
- TIAC (≥ 2 cas) → ARS ; RappelConso ; nutrivigilance.
- Surveillance = déf. CDC (collecte systématique et continue, analyse, interprétation, diffusion). INCA 3 = 2014-15 (publiée 2017) ; ESTEBAN 2014-16 ; Albane = SpF + ANSES, juin 2025, tous les 2 ans, résultats 2028. RappelConso depuis avril 2021.
- Diét. = utilisateur des données (diagnostic) et parfois producteur (enquêteur, signalement TIAC, nutrivigilance).

② **Promotion de la santé** – **Ottawa 21/11/1986** : « conférer aux pop. les moyens d'un plus grand **contrôle sur leur santé** ».

- **5 domaines** = « **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement » : Politique saine · Milieux favorables · action Communautaire · Aptitudes individuelles · Réorienter les services.
- **3 stratégies** : plaider · conférer les moyens · servir de médiateur.
- Principes : DT, participation, empowerment, intersectorialité, milieux de vie, non-stigmatisation.
- **Dahlgren & Whitehead 1991** (centre → ext.) : 1 âge-sexe-hérédité · 2 style de vie · 3 réseaux sociaux · 4 conditions de vie et travail · 5 conditions socio-éco-culturelles-environnementales.
- **Universalisme proportionné** (Marmot 2010) : pour tous, + intense pour les + défavorisés.
    - évite 2 écueils : universel seul → profite aux favorisés ; ciblé seul → stigmatise, oublie le gradient social. Ex. : cantine pour tous + tarif social (cantine à 1 €, 2019) + appui en QPV.
- Exemples des 5 domaines : EGalim, Nutri-Score (politique) · fontaines, pas de distributeurs (milieux) · jardin partagé (communautaire) · atelier cuisine (aptitudes) · prévention en MSP, CPTS (services).
- **Conférences** : Alma-Ata 1978 (soins de santé primaires, santé pour tous en 2000) · Ottawa 1986 · Adélaïde 1988 (politiques favorables, nutrition) · Jakarta 1997 (partenariats) · Bangkok 2005 (mondialisation) · Adélaïde 2010 + Helsinki 2013 (santé dans toutes les politiques) · Shanghai 2016 (ODD, littératie) · Genève 2021 (bien-être).
- Villes-Santé OMS (réseau français 1990), écoles promotrices de santé.
- Lecture Dahlgren : agir sur les couches externes (prix, offre, revenus) → touche + de monde, ↓ inégalités ; agir seulement au centre → effet limité.

③ **Prévention** – OMS 1948 : éviter ou réduire nombre et gravité des maladies.

OMS (moment)	effet	ex.
Primaire	↓ **incidence**	repères PNNS, atelier
Secondaire	↓ **prévalence** (dépistage)	dénutrition EHPAD
Tertiaire	↓ complications	ETP (BC1)
Quaternaire (Jamoulle 1986)	↓ surmédicalisation	régimes inutiles

- **Gordon 1983** (public) : universelle · sélective (groupe à risque) · indiquée (FR présents). Indépendant de l'OMS.
    - ex. : universelle = « Manger Bouger », menu végé · sélective = ateliers petit budget en QPV, 1000 premiers jours en précarité · indiquée = enfants en surpoids (« Mission : retrouve ton cap »).

- Secondaire en nutrition : courbes de corpulence en PMI (rebond d'adiposité), dépistage dénutrition, diabète de type 2.
- **San Marco 2003** : prévention globale (centrée sur la personne) ≠ prévention de maladies.

④ **EPS** – PNES 2001 : compétences + moyens pour sa santé et celle de la collectivité.

- 3 formes : **nutritionnelle** (étiquette) · **alimentaire** (cuisiner, budget) · **sensorielle** (Puisais 1975, Semaine du goût 1990).
- Approches : informative → persuasive (culpabilise) → **participative** ✔. CPS (2022-2037).
- CPS : référentiel SpF 2022 ; stratégie nationale 2022-2037.
- **Marketing social** (4 P, Change4Life) ; **nudges** (Thaler & Sunstein 2008 : fruits à hauteur des yeux, eau par défaut) → utiles mais ≠ action sur DT structurels.
- Un même thème, 4 modes (boissons sucrées) : surveillance (ESTEBAN) · PS (taxe soda 2012/2018/2025, fontaines, distributeurs interdits 2004) · prévention sélective (écoles d'un quartier) · EPS (atelier eaux aromatisées).

+ CNED : sécurité sanitaire (veille → expertise → gestion → communication) ; restauration de la santé = soin, hors BC3.

- Sécurité sanitaire : principe de précaution (Charte de l'environnement 2005, art. 5). Chaîne TIAC : médecin → ARS → enquête ARS + DDPP ; SpF analyse ; labo (plats témoins 5 jours) → ANSES évalue → préfet/ministère retire ou rappelle (RappelConso).

Emboîtement : PS ⊃ prévention ⊃ EPS ; **ETP à part** (patients, maladie chronique, HPST 2009, déclarée à l'ARS).

- Tableau à savoir : PS = pop., DT, Ottawa/SNS/PRS · prévention = groupe exposé, maladie ou FR, OMS 1948/Gordon 1983 · EPS = bien portants, besoins éducatifs, PNES 2001 · ETP = patients, diagnostic éducatif, art. L. 1161-1 CSP, HAS 2007.

Oral E5 en 4 phrases : mode → prévention (OMS + Gordon) → démarche de PS → politiques (PNNS 5, PRS, CLS).

5. Acteurs

- **4 types (CNED)** : décideur (DGS, DGAL, ARS) · consultatif (HCSP, CNS, CNA, CRSA) · opérateur (SpF, CCAS, assos, **diét.**) · financeur (ARS-FIR, Assurance maladie-FNPEIS, collectivités).
- Monde/UE : OMS (sucres < 10 %, sel < 5 g), FAO, Codex, EFSA (Parme 2002), INCO 1169/2011 (14 allergènes).
- National : **ANSES** 2010 (INCA, Ciqual, Oqali) · **HAS** 2004 · **HCSP** 2004 (avis PNNS 5 juin 2025) · CNA 1985.
  - Dénutrition : HAS + FFN 2019 (enfant, adulte) ; **HAS + FFAMCO 2021** (≥ 70 ans).
- Données : Insee, Drees, CépiDc, SpF, ANSES, Assurance maladie (SNDS), ORS, Crédoc, EREN.
- Région : **ARS** (PRS, FIR, appels à projets, CLS, ETP) · CRSA · DRAAF (PAT) · ORS · Promotion Santé.
- Local : PMI (département), CCAS et cantine (commune), CAF, MSP/CPTS, assos.
- **Démocratie sanitaire** (loi 4/03/2002) : droits individuels (info, consentement, dossier) + collectifs (assos agréées). Instances : CNS → CRSA → conseil territorial → commission des usagers.
- Démocratie sanitaire : après le sang contaminé ; complétée 2009 et 2016 ; **France Assos Santé** (2016-2017). Pour le diét. : associer les habitants au comité de pilotage.
- Sigles à jour : HCSP (≠ « Haut Comité »), CRSA (≠ CRS), territoires de démocratie sanitaire + conseils territoriaux (≠ « territoires de santé »).
- Autres nationaux : DGCCRF (étiquetage, RappelConso), Éducation nationale (écoles promotrices), Transition écologique (SNANC, loi AGEC), INCa (NACRe), Assurance maladie (SNDS, Mission retrouve ton cap), EREN (NutriNet).
- International : FAO (Rome 1945, CIN2 2014), Codex (1963), UNICEF (Hôpital ami des bébés), ODD 2/3/12, RASFF (alertes UE), EUFIC (financé par l'industrie). OMS : allaitement exclusif 6 mois.
- Région/local : DREETS (Mieux manger pour tous 2023), conseil régional (lycées), CSO, département (PMI, APA, collèges), CCAS (épiceries, portage), CAF (centres sociaux), contrats de ville (Engagements Quartiers 2030).
- Calcul : part d'un financeur = montant / budget total × 100.

6. Politiques publiques

- Outils : loi (Parlement) · règlement (décret, arrêté) · stratégie · plan · financement.
- **6 étapes** : agenda → élaboration → décision → mise en œuvre → suivi → évaluation.
- **SNS** : dernière adoptée **2018-2022** ; 2023-2033 = **projet non adopté**.

- **PRS** (ARS) = COS 10 ans + SRS 5 ans + PRAPS. **CLS** = ARS + collectivité. **PAT** = loi 13/10/2014 (≈ 450 ; objectif 80 % du territoire).
- Logique descendante (SNS → PRS → CLS) + ascendante (besoins locaux).
- SNDS = remboursements → ne mesure pas l'obésité (→ enquêtes).
- Politique publique = décisions + actions des pouvoirs publics pour un problème reconnu public (objectifs, moyens, acteurs).
- Ex. d'outils : loi 2004, EGalim 2018, Climat 2021 · arrêtés Nutri-Score 2017/2025, décret repas scolaires 30/09/2011 · SNS, SNANC · PNNS 5, PNA 4 · FIR, appels à projets.
- Agenda ex. : obésité infantile années 1990 → PNNS 1. Évaluation par HCSP, IGAS, Cour des comptes → plan suivant.
- Loi 2016 art. 14 = Nutri-Score facultatif. Comité interministériel pour la santé (2014).
- Planification sanitaire = prévoir les actions par priorité dans le cadre de la SNS (ARS via PRS). Territoire de démocratie sanitaire (ARS, 2016).
- PRS 3e génération : 2023-2028 (COS → 2033). CLS : art. L. 1434-10 CSP. Contrats de ville (QPV, ASV).
- SNDS = Assurance maladie + PMSI + CépiDc (Cnam) ; Health Data Hub (loi 24/07/2019, ex-INDS).
- **Architecture** : monde/UE → SNS, SNANC → PNNS 5, PNA 4, lois → ARS-PRS, DRAAF → CLS, PAT, communes, diét.

7. Politiques nutritionnelles

- **Chiffres** : obésité adulte **18,1 %** (OFÉO 2024, déclaré) / 17 % (ESTEBAN, mesuré) · enfants 6-17 ans **17 %** surpoids dont 4 % obésité · précarité alim. **16 %** · 5 F&L : 30 % adultes · EV 85,9 F / 80,3 H · écart riches/pauvres ≈ 13 ans.
- **Frise** : PNNS 1 (2001) → 2 (2006) → 3 (2011) → 4 (2019-23) → **PNNS 5 (2026-30)** · PNA 2010 · Nutri-Score 2017 · EGalim 2018 · Climat 2021 · algorithme NS 14/03/2025.
- **SNANC 2025-2030** : loi Climat **art. 265** ; publiée **11/02/2026** ; santé + écologie + souveraineté ; oriente PNNS et PNA.
- **PNNS 5 + PNA 4** lancés **8/04/2026** (One Health Summit, Lyon). PNNS 5 : **3 axes, 20 mesures**, **− 30 %** surpoids/obésité enfants (− 20 % défavorisés).
- **Repères 2019** : ↑ F&L 5/j, légumes secs 2/sem, fruits à coque, 30 min d'activité · → complets, colza-noix-olive, poisson 2/sem, 2 laitiers · ↓ alcool ≤ 10 verres/sem, sucré ≤ 1 verre/j, charcuterie 150 g/sem, viande 500 g/sem, sel.
- **EGalim** : ≥ **50 %** durables dont ≥ **20 % bio** ; 60 % viandes-poissons ; menu végé hebdo. Bilan 2023 : 25,5 % / 12,1 %.
- **Nutri-Score** : **facultatif**, EREN ; seule l'eau = A.
  - adopté 31/10/2017 ; 7 pays ; algorithme 14/03/2025 (2 ans de transition) : + huiles insaturées, poissons gras, complets ; − sel, sucre, boissons édulcorées.
- Autres chiffres : 49 % surpoids adulte mesuré · fibres < 25 g pour 90 % · sel ≈ 9 g (H) / 7 g (F) · 42 % des 6-17 ans à 60 min d'activité · 22,2 % de 65 ans et + · obésité 22,4 % outre-mer, 24,7 % si difficultés éco.
- Lire un chiffre : année de recueil, pop., méthode (mesuré/déclaré), source.
- PNNS 1 : 9 objectifs chiffrés, guide « La santé vient en mangeant » 2002 · PNNS 2 : chartes industriels, Oqali 2008 · PNNS 3 : inégalités, dénutrition · PNNS 4 : 5 axes, 55 actions + PNA 3 = PNAN.
- **SNANC** : 3 axes = alimentation saine pour tous · ↓ impact climat · soutenir agriculteurs ; 80 % du territoire en PAT.
- **PNNS 5** : DGS ; axes = environnements durables · comportements sains · milieux de vie promoteurs de santé ; objectifs : 12 % bio, 40 % utilisent le NS, 75 % des produits avec NS, 85 % allaités ; mesures : marketing enfants (ARCOM 2025-29), − sucres produits enfants, 1000 jours, dénutrition âgés ; activité physique → Stratégie sport-santé ; ultra-transformés → définition ANSES.
- **PNA** : Agriculture, loi 27/07/2010 ; restauration collective, gaspillage, éducation alim., justice sociale, PAT.
- Autres leviers : taxe soda · loi 20/12/2016 (pas de pub jeunesse TV publique) · 1000 premiers jours (2020, Cyrulnik) · Mieux manger pour tous (2023) · cantine à 1 € + petits-déj gratuits (2019) · Villes actives PNNS.
- EGalim : depuis 1/01/2022, en valeur HT ; 60 % viandes-poissons depuis 2024 (100 % État) ; plan protéines > 200 couverts ; « ma cantine ».

8. Diététicien et projet

- CSP **L. 4371-1** ; titre protégé (« nutritionniste » non).

- Ne fait pas : diagnostic médical, régime à un participant, pub de marque, photos sans accord.
- **Projet (Afnor)** = processus unique, début + fin, objectif, contraintes de délais, coûts, ressources. Projet ⊃ action ⊃ atelier.
- **6 étapes** : diagnostic (F1-F2) → objectifs SMART (F3) → conception (F4-F6) → mise en œuvre (F7-F10) → évaluation (F11-F12) → valorisation (F13-F14).
- **Bradshaw 1972** : normatif (expert) · ressenti (pop.) · exprimé (demande) · comparatif.
- **SMART** : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel.
- Calculs : coût/portion = total / portions · taux = réalisé / prévu × 100 · EGalim = achats catégorie / total × 100.
- Missions (AFDN 2022) : diagnostic de territoire · concevoir-animer-évaluer · outils (littératie) · former des relais · conseiller les décideurs · études · veille · réseaux (CLS, PAT).
- Posture : respect, pas de culpabilisation, partir des besoins, partenariat, infos datées-sourcées, pas de conflit d'intérêts, secret, RGPD, droit à l'image.
- Projet de SP = diagnostic partagé + pop. + évaluation (inégalités). Vocabulaire : appel à projets, parties prenantes, valorisation, capitalisation.
- Données froides (stats) + chaudes (questionnaires, entretiens). Outils : QQOQCP, arbre à problèmes/objectifs, Ishikawa, SWOT, champs de forces (Lewin), carte mentale.
- Arbre à problèmes : causes en bas, conséquences en haut. Objectifs : général → spécifiques → opérationnels.
- Bradshaw : + besoins observés ; besoin dans plusieurs cases = prioritaire ; « ressenti » jamais par les professionnels.
- **Fil rouge** (fictif) : centre social des Tilleuls, Valmont (QPV) ; Inès ; « Bien manger, petit budget, grand plaisir » ; 6 ateliers × 3 h, 12 familles ; ARS 1 500 € ; repas 1,38 €/pers. ; score 4,75 → 7,17/10 ; légumes secs 25 % → 75 %.
- Stats : moyenne = somme / n ; médiane = milieu de la série ; écart-type s = √[Σ(x − moyenne)² / (n − 1)].

9. À ne pas oublier

- NOVA (Monteiro 2009) = transformation ≠ Nutri-Score = composition.
- Non-stigmatisation : « personne vivant avec une obésité ».
- Climat : 200 g de lentilles ≈ 20 g de protéines ≈ 85 g de steak.
    - 16,7 g de fibres, 4,9 mg de fer (non héminique → vitamine C). Alimentation ≈ ¼ de l'empreinte carbone ; EAT-Lancet 2019 ; HCSP : ≈ − 50 % de viande.
- **Données probantes** = recherche + expérience des pros + savoirs des personnes ; registre SpF ; chercher → vérifier → transférabilité → citer ; multi-composantes > information seule.
- **Changement de comportement** : Health Belief Model (Rosenstock) · transthéorique (Prochaska & DiClemente 1983 : précontemplation → contemplation → préparation → action → maintien) · Bandura (efficacité personnelle).
- NOVA : 1 peu transformé · 2 ingrédient culinaire · 3 transformé · 4 ultra-transformé. Bio = mode de production.
- Stigmatisation (Nature Medicine 2020) : « bien manger et bouger en famille », « aliments à limiter », pas de pesée en public.
- **L3** : capabilités (Sen) · syndémie mondiale (Swinburn, Lancet 2019) · évaluation réaliste (Pawson & Tilley 1997 : contexte-mécanisme-effet) · déterminants commerciaux (OMS, Lancet 2023).

Pièges : PNNS 4 ≠ en vigueur · SNS 2023-2033 non adoptée · Nutri-Score non obligatoire · dépistage = secondaire · ETP ≠ EPS · incidence ≠ prévalence · mesuré ≠ déclaré · « ressenti » = la population · un atelier ≠ un projet.